SDD 223 Sujet n°2

Spécialité : Hématologie

Date : 09/10/2023
Auteur : Alexandre IAT
Relecteur(s) : Dr Lin-Pierre Zhao / ELAYLI Robin / Lucie-Lou VIAl

/!\ N'oubliez pas d'indiquer sur le tableur d'avancement que vous construisez une station ECOS

Domaine d'apprentissage principal	Entretien/interrogatoire
Domaine d'apprentissage secondaire	Examen clinique
Item(s) en lien avec la station	212 – Analyse de l'hémogramme 213 – Neutropénie
Situation(s) de départ en lien avec la station	223 – Analyse de l'hémogramme
Matériel nécessaire à la station	Aucun
Contexte de la station	Consultation aux urgences

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes médecin urgentiste et vous recevez aux urgences Mr D, un patient de 37 ans qui présente des douleurs oropharyngées résistantes à une antibiothérapie par Amoxicilline prescrite par son médecin traitant.

Monsieur D présente aussi une asthénie marquée depuis 10 jours d'évolution rapidement progressive initialement à l'effort et à présent au repos, l'apparition de saignements à type d'épistaxis, lors brossage des dents et un goût de sang récurrent dans la bouche. Voici les résultats de son bilan sanguin :

- Hémoglobine : 8,1 g/dL, VGM : 89 fl, CCMH : 33,9 g/dL
- Leucocytes : 1,5 G/L dont PNNs : 0,4 G/L et lymphocytes : 0,8 G/L, blastes 2%
- Plaquettes : 20 G/L
- Créatinine : 70µmol/L soit un DFG à 93 mL/min/1,73 m^2
- CRP : 156 mg/L
- ASAT : 56 U/L, ALAT : 45 U/L
- TP : 90%, TCA : 30 secondes, ratio TCA patient/TCA témoins : 1,1, Fibrinogène : 2,5g/L
- Acide urique : 310 mmol/L
- Sodium : 137 mmol/L
- Chlorure : 101 mmol/L
- Potassium : 3.7 mmol/L
- Calcium corrigé : 2.4 mmol/L
- Phosphore : 1.2 mmol/L

Ce bilan sanguin évoque une pancytopénie en lien avec une suspicion de leucémie aiguë

Consignes :

Vous avez 8 minutes pour :
- Réaliser l'interrogatoire de la patiente
- Enoncer les éléments à rechercher à l'examen clinique dans ce contexte, en justifiant

Vous ne devez pas :
- Enoncer le traitement
- Enoncer les examens complémentaires à réaliser

Il s'agit d'une station avec patient standardisé

ECOS TACFA
GRILLE D'EVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques (max 15 items)		
1.	Recherche ATCD familiaux ET personnels de maladie hématologique	1 pt
2.	Demander une NFS antérieure	1 pt
3.	Interroger sur l'altération d'état général : ● Perte de poids ● Asthénie ● Sueurs nocturnes	1 pt ok si 3 sur 3
4.	Interroger sur les traitements pris par le patient	1 pt
5.	Recherche des expositions professionnelles ET extra-professionnelle à des carcinogènes possibles	1 pt
6.	Interroger sur les antécédents ORL et sur les documentations infectieuses réalisées et sur les symptômes actuels : - Recherche d'odynophagie ● Recherche si un TROD streptocoque a-t-il été réalisé ? ● Recherche de l'effet de l'antibiothérapie initiée ● Recherche de rapports sexuels à risque infectieux	1 pt ok si 2
7.	Prise de constantes - Prise de température - Prise de pression artérielle - Prise de la fréquence cardiaque - Saturation	1 pt ok si 3
8.	Recherche de point d'appel infectieux vu le contexte de neutropénie ● ORL : examen de la cavité buccal (IMPÉRATIF) ● Digestif : interroger sur les symptômes digestifs ou la présence ou non de douleurs, ou palpation abdominale à la recherche de douleur ● Neurologique : recherche ○ Céphalées OU photophobie OU phonophobie	1 pt ORL + 1 / 2

	○ ET une raideur de nuque	
	Recherche de point d'appel infectieux vu le contexte de neutropénie ● Respiratoire : interrogatoire sur la toux ou crachats ou dyspnée, ou auscultation (à la recherche de foyers infectieux) ● Urinaire : recherche de signes fonctionnels urinaires ou percussion des fosses lombaires ● Examen cutané : interrogatoire à la recherche de lésions ou de plaies, ou examine les membres inférieurs, supérieurs et visage	1 pt ok si 2 / 3
	Recherche de syndrome hémorragique : - Examen de la cavité buccale à la recherche de saignement - Digestif : interrogatoire sur présence de sang dans les selles, lors d'effort de vomissement	1 pt ok si 2/2

	Recherche de syndrome hémorragique :
	- Urinaire : interrogatoire seulement (demande si présence de sang dans les urines)
	
	- Neurologique : examen moteur avec les 3 éléments suivants :
	  - Lever les bras
	  - Lever les jambes
	  - Recherche d'asymétrie au niveau du visage (au repos, puis demande de gonfler les joue OU de sourire OU de fermé les paupière contre résistance)
		1 pt
		
		ok si 1/ 2

	Recherche des signes de mauvaise tolérance de l'anémie : - Dyspnée - Lipothymies - Confusion - Douleurs thoraciques	1 pt ok si 3 / 4
	Recherche d'un syndrome tumoral : ● Recherche de gonflement gingival ● Hépatomégalie *(Demande au patient d'inspirer profondément et appui en hypochondre droit à l'inspiration)* ● Splénomégalie *(De même mais en hypochondre gauche)*	1 pt ok si 3 / 3

	Recherche d'un syndrome tumoral : Examen des aires ganglionnaires : - cervicales - axillaires - inguinales	1 pt
Communications et attitudes (ICI) (max 5 grilles)		*4 pts*
	2. APTITUDE À QUESTIONNER	*1 pt*

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Pose des questions fermées ou trop directives ou qui ne répondent pas aux objectifs Utilise le jargon médical	Pose des questions qui s'éloignent des objectifs Utilise quelques fois un jargon médical sans explication	Utilise différents types de questions couvrant les éléments essentiels Utilise quelques fois un jargon médical mais toujours avec explications	Pose des questions précises couvrant la plupart des éléments avec quelques omissions mineures Utilise le langage approprié	Pose les questions avec assurance et savoir-faire

	4. APTITUDE À STRUCTURER/ MENER L'ENTREVUE	*1 pt*

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Approche désordonnée	Entrevue peu structurée, présente les difficultés à recadrer les discussions qui s'éloignent des objectifs	Entrevue centrée sur le problème et couvre les éléments essentiels	Entrevue menée de façon logique, structurée, centrée sur le problème, ne cherche pas l'information non pertinente	Entrevue ayant un but précis, approche intégrée

	5. COMMUNICATION NON VERBALE	*1 pt*

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Se comporte de manière inappropriée (p. ex. ne regarde pas son interlocuteur, se comporte de manière offensante ou agressante) ou porte des jugements	Tente d'établir un contact visuel. Présente les difficultés à établir la conversation (p.ex. priorise l'accomplissement de la tâche clinique) et cela peut induire la frustration du patient/pair	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Établit la conversation	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Est attentif aux indices du patient/pair et réagit de manière appropriée par son comportement/gestes.	Montre une bonne maîtrise de ses comportements et cherche à les adapter afin de favoriser la conversation /établir une relation.

	10. APTITUDE À MENER L'EXAMEN CLINIQUE	*1 pt*

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
N'explique pas au patient les gestes réalisés ou ne respecte pas le confort du patient	Explique peu les gestes réalisés	Explique les gestes réalisés et respecte le confort du patient	Donne l'information sur les gestes en expliquant les objectifs /les éléments recherchés et respecte le confort du patient	Agit sans erreur Met à l'aise

TOTAL (max 20 items) sur 20 points	points

Éléments de rétroaction :

ECOS TACFA
SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Bilan d'une neutropénie

Plan de la station ECOS :

Assis sur un brancard dans un box aux urgences

Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :

Bonjour Docteur, Je me sens mal depuis 10 jours maintenant entre une angine qui m'empêche de manger, un goût de sang dans la bouche, une fatigue à ne plus réussir à me déplacer sans devoir m'arrêter et des douleurs dans les os.

Identité du patient :

Monsieur J. D., 37 ans, 75 kg, 1m75

Mode de vie :

- Divorcé, un enfant, vit seul avec la garde alternée de sa fille - Travaille au-dessus de l'autoroute comme contrôleur de trafic - Ne prend pas de traitement au quotidien mais a eu des ordonnances la semaine

passée et s'est auto-médiqué récemment pour les douleurs
- Pas d'alcool, pas de tabac
- Pas d'allergie

Comportement global :

Patient inquiet, douloureux au niveau de la gorge, très fatigué

Antécédents personnels :

0

Antécédents familiaux :

0

Médicaments :

Traitement récents : AMOXICILLINE 7 jours, Paracétamol
Traitement de fond : aucun

Symptômes positifs :

Si recherche de sueurs, présence de sueurs nocturnes
Si examen buccal, il observe un aspect ulcéro-nécrotique des amygdales, un aspect rouge du voile du palais, des bulles rouges sur la face interne des joues.

Si demande d'examen cutanée, parler d'une pâleur conjonctivale, pâleur cutanée, présence de lésion ne s'effaçant pas à la vitropression sur l'ensemble du corps
Si palpation ganglionnaire, noter la présence d'adénopathies centimétriques cervicales sans autres éléments tumoraux
Si palpation foie+rate, pas de splénomégalie, hépatomégalie

Constantes :

FC 115, TA 100/60, SatO2 98%, T 38,5°C

Donnée complémentaire :

Bilan sanguin fourni dans l'énoncé Ordonnance d'Amoxicilline datant de 7 jours plus tôt : Amoxicilline 1gx3 pour une durée de 7 jours

NE PAS OUBLIER DE METTRE LE DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE SUR LE DRIVE

Questions de relance :

Aucune